

INFORME DE EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA

— Variante Profesional —

PACIENTE

Jorge Eliécer Salazar Pinzón

DOCUMENTO

CC 79555111

FECHA NACIMIENTO

08/11/1980

EDAD

46 años, 2 meses

SEXO

Masculino

ESCOLARIDAD

Tecnólogo

LATERALIDAD

Diestro

FECHA DE EVALUACIÓN

12/01/2027

ORDEN N°

Auto del 2026-05-20

PROTOCOLO APLICADO

peritaje_medicolegal_adulto

INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA

Nombre:	Jorge Eliécer Salazar Pinzón	Lateralidad:	Diestro
Documento:	CC 79555111	Ocupación:	Técnico electricista (incapacitado por el ...
Fecha de nacimiento:	08/11/1980	Ciudad:	Bogotá, D.C.
Edad:	46 años, 2 meses	Acompañante:	Esposa Diana Ramírez
Sexo:	Masculino	Remite:	Juzgado 14 Laboral del Circuito — Rad. 2...
Escolaridad:	Tecnólogo	EPS / Asegurador:	Sanitas EPS

MOTIVO DE CONSULTA

PERITAJE NEUROPSICOLÓGICO ordenado por Juzgado 14 Laboral del Circuito. Paciente sufrió TEC moderado en accidente laboral el 2025-08-15 (caída de 4 metros). Demanda en curso contra la empresa constructora. La evaluación es para DETERMINAR SECUELAS COGNITIVAS y capacidad laboral residual.

PRUEBAS APLICADAS

Protocolo: peritaje_medicolegal_adulto

Prueba	Dominio	Dur.
VOCABULARIO	Comprensión Verbal	—
COMPRENSIÓN	Comprensión Verbal	—
CONSTRUCCIÓN CUBOS	Organización Perceptual	—
FIG. INCOMPLETAS	Organización Perceptual	—
HISTORIETAS	Organización Perceptual	—
INFORMACIÓN	Comprensión Verbal	—
LETRAS Y NÚMEROS	Memoria de Trabajo	—
ROMPECABEZAS	Organización Perceptual	—
Figura de Rey	Memoria Visuoespacial	—
Inventario de Beck BDI-II	Socioemocional - Depresión	—

ANTECEDENTES

Patológicos / Médicos

Sin antecedentes médicos de relevancia.

Farmacológicos

Sin medicación actual.

Familiares

Sin antecedentes neuropsiquiátricos de primer grado.

Psiquiátricos

Sin antecedentes psiquiátricos previos.

Traumáticos

Niega TEC previo.

RESUMEN EJECUTIVO

Pirámide invertida: conclusión, hallazgos, implicación

Conclusión

Perfil neuropsicológico global: $Z = +0.7\sigma$ sobre 4 dominios evaluados.

Hallazgos clave

- Memoria Visuoespacial moderadamente descendido ($Z = -1.3\sigma$)
- Memoria de Trabajo preservado ($Z = +3.0\sigma$)

Implicación

Se sugiere intervención dirigida al dominio descendido, con monitoreo de respuesta a tratamiento.

OBSERVACIÓN CLÍNICA

Hallazgos cualitativos durante la administración

Apariencia y conducta

Evaluación neuropsicológica. Paciente colaborador.

Atención y concentración

Atención sostenida severamente comprometida. TMT-A normal pero TMT-B en percentil <1. Stroop con alta interferencia (errores x3 sobre lo esperado). Estilo de respuesta lento-cauteloso, sugerente de déficit en velocidad de procesamiento más que impulsividad.

Memoria

Memoria de trabajo auditiva descendida (dígitos inversos en percentil 16). Memoria verbal con curva de aprendizaje aplanada y alta tasa de intrusiones (FCRO Rey percentil 25).

Praxias y gnosias

Sin alteraciones significativas en praxias ni gnosias.

Lenguaje

Lenguaje expresivo conservado pero con latencias aumentadas. Comprensión auditiva intacta para material concreto, descendida para inferencias. Discurso con pausas y autocorrecciones frecuentes.

Funciones ejecutivas

Funciones ejecutivas GLOBALEMENTE descendidas. WCST con 4 categorías completadas (esperado 6). Errores perseverativos aumentados. Flexibilidad cognitiva severamente afectada (TMT-B).

Cociente intelectual (observación)

Perfil cognitivo: F07.2 - Síndrome post-concusional + demanda laboral activa

RESULTADOS CUANTITATIVOS

Puntajes por prueba y perfil cognitivo del paciente

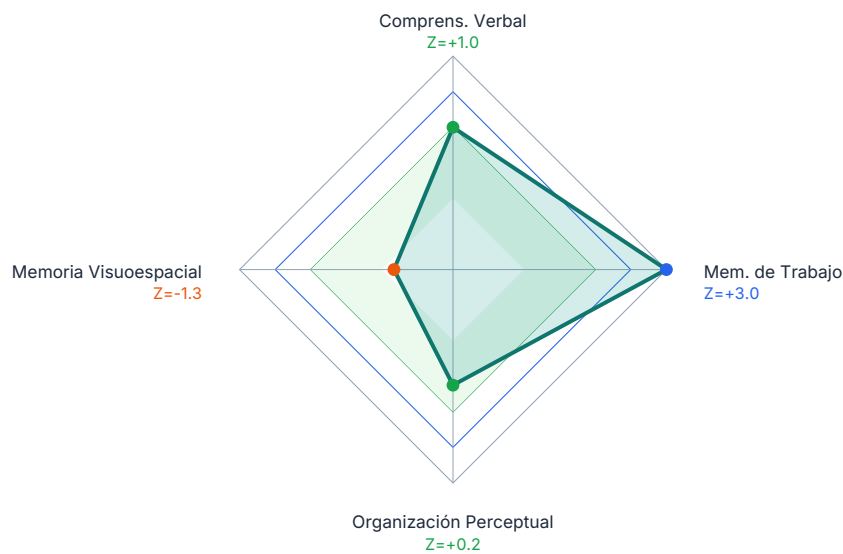
Inventario de Be

18

Leve

Perfil cognitivo por dominio

Cada eje representa un dominio cognitivo. El polígono teal muestra el Z del paciente; la franja verde central equivale al rango normal (-1 a +1 σ).

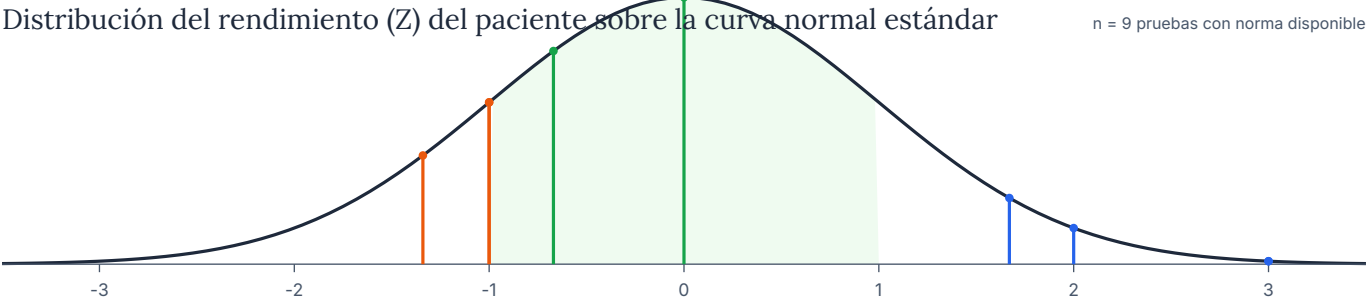


Curva normal con puntajes Z del paciente

Eje horizontal: puntaje Z (unidades de desviación estándar). Las marcas rojas son los puntajes del paciente sobre la curva.

Distribución del rendimiento (Z) del paciente sobre la curva normal estándar

n = 9 pruebas con norma disponible



Perfil Z por prueba

PRUEBA	-3	-2	-1	0	1	2	3 Z
--------	----	----	----	---	---	---	-----

Perfil Z por prueba

Eje horizontal: puntaje Z (rango -3 a +3). Verde = zona normal; rojo/naranja = debajo del promedio; azul = por encima.

PRUEBA	-3	-2	-1	0	1	2	3 Z
VOCABULARIO							-0.67
COMPRENSIÓN							+2.00
CONSTRUCCIÓN CUBOS							-1.00
FIG. INCOMPLETAS							+0.00
HISTORIETAS							+3.00
INFORMACIÓN							+1.67
LETRAS Y NÚMEROS							+3.00
ROMPECABEZAS							-1.00
Figura de Rey							-1.34
Inventario de Beck BDI-II							-5.47

Banda verde = rango normal (-1 a +1 σ). Z < -1 sugiere debilidad. Z > +1 sugiere fortaleza relativa.

Semáforo de dominios cognitivos

DOMINIO	Z ⁻	BANDA
● Memoria Visuoespacial	-1.34σ	moderado
● Organización Perceptual	+0.25σ	promedio
● Comprensión Verbal	+1.00σ	promedio
● Memoria de Trabajo	+3.00σ	superior

Tabla detallada de puntajes

Prueba	PD	Escalar/CI	Z	Interpretación
VOCABULARIO	32	8	-0.67	Promedio
COMRENSIÓN	28	16	+2.00	Superior
CONSTRUCCIÓN CUBOS	24	7	-1.00	Promedio
FIG. INCOMPLETAS	19	10	+0.00	Promedio
HISTORIETAS	22	19	+3.00	Superior
INFORMACIÓN	25	15	+1.67	Superior
LETRAS Y NÚMEROS	21	19	+3.00	Superior
ROMPECABEZAS	20	7	-1.00	Promedio
Figura de Rey	25	-1	-1.34	Límitrofe
Inventario de Beck BDI-II	18	18	-5.47	Leve

SÍNTESIS CLÍNICA INTEGRADORA

Lectura cuantitativa de los hallazgos

El perfil neuropsicológico evidencia debilidades en: memoria visuoespacial (moderadamente disminuido, $Z=-1.3$). Por su parte, destacan como áreas preservadas o por encima del promedio: memoria de trabajo (muy alto, $Z=+3.0$); comprensión verbal (alto, $Z=+1.0$).

Entre las pruebas con mayor desviación se encuentran Figura de Rey ($Z=-1.34$, límiterofe); CONSTRUCCIÓN CUBOS ($Z=-1.00$, promedio); ROMPECABEZAS ($Z=-1.00$, promedio). Estos hallazgos orientan la formulación diagnóstica y la priorización de objetivos de intervención.

Áreas con desempeño disminuido

- Figura de Rey — límiterofe ($Z=-1.34$)
- CONSTRUCCIÓN CUBOS — promedio ($Z=-1.00$)
- ROMPECABEZAS — promedio ($Z=-1.00$)

Áreas con desempeño preservado / superior

- HISTORIETAS — superior ($Z=+3.00$)
- LETRAS Y NÚMEROS — superior ($Z=+3.00$)
- COMRENSIÓN — superior ($Z=+2.00$)
- INFORMACIÓN — superior ($Z=+1.67$)

RESUMEN PARA LA FAMILIA

Lenguaje sencillo para padres, cuidadores y paciente

Saludo

Este es un resumen de la evaluación que se realizó Jorge. Está escrito en un lenguaje sencillo para que sea fácil de entender. Tu psicólogo o psicóloga te explicará los detalles y resolverá cualquier duda que tengas.

¿Qué hicimos en la evaluación?

Realizamos varias pruebas que miden cómo funciona tu cerebro en distintas situaciones: memoria, atención, lenguaje, razonamiento y la velocidad con la que procesas información. Las pruebas son como "pequeños retos" que se resuelven con papel, lápiz y a veces con cubos o figuras. No hay respuestas buenas ni malas: lo que nos interesa es conocer cómo trabaja tu mente.

¿Qué encontramos?

Las áreas donde te fue bien incluyen: En VOCABULARIO, tu rendimiento fue dentro del rango esperado. En COMRENSIÓN, tu rendimiento fue muy por encima del promedio. En CONSTRUCCIÓN CUBOS, tu rendimiento fue dentro del rango esperado. Las áreas donde se recomienda trabajar incluyen: En Figura de Rey, tu rendimiento estuvo en el límite (Limitrofe). Vale la pena acompañarlo de cerca.

Implicaciones para la vida diaria

Además de los puntajes, esto es lo que podría notarse en la vida cotidiana:

Memoria Visuoespacial · moderado

- Tareas que dependen de esta función pueden requerir más esfuerzo o tiempo.
- Rendimiento bajo comparado con pares de la misma edad y escolaridad.

Apoyos sugeridos: Practicar con constancia y paciencia. · Acompañar el proceso con apoyo profesional y familiar.

Áreas para apoyar (en qué trabajar)

- En VOCABULARIO, tu rendimiento fue dentro del rango esperado.
- En COMRENSIÓN, tu rendimiento fue muy por encima del promedio.
- En CONSTRUCCIÓN CUBOS, tu rendimiento fue dentro del rango esperado.
- En FIG. INCOMPLETAS, tu rendimiento fue dentro del rango esperado.
- En HISTORIETAS, tu rendimiento fue muy por encima del promedio.
- En Figura de Rey, tu rendimiento estuvo en el límite (Limitrofe). Vale la pena acompañarlo de cerca.

¿Qué recomendamos?

Recomendación: [LABORAL] Paciente presenta SECUELAS COGNITIVAS SIGNIFICATIVAS compatibles con síndrome post-concusional crónico. Capacidad laboral residual estimada: 40-50% de su nivel pre-lesional. (consulta con tu psicólogo/a para detalles específicos). Recomendación: [LABORAL] Implicaciones para la demanda: Las alteraciones en funciones ejecutivas y memoria documentadas SON CONSISTENTES con el TEC moderado del 2025-08-15 (mecanismo plausible, temporalidad coherente, perfil neuropsicológico típico). (consulta con tu psicólogo/a para detalles específicos). Recomendación: [LABORAL] Limitaciones específicas: no apto para trabajo en alturas, no apto para tareas que requieran alta velocidad de procesamiento o toma rápida de decisiones en condiciones de riesgo. Requiere supervisión y pausas estructuradas. (consulta con tu psicólogo/a para detalles específicos). Recomendación: [LEGAL] Documentación completa disponible para el juzgado. Se anexa: batería administrada, resultados normativos, análisis de validez, correlación anátomo-clínica, y respuesta a cada pregunta del auto interlocutorio. (consulta con tu psicólogo/a para detalles específicos).

Preguntas frecuentes

¿Mis resultados son permanentes?

No necesariamente. El cerebro puede cambiar con el tiempo, especialmente con práctica, con los apoyos adecuados y con un buen ambiente. Estos resultados son una foto del momento actual: tu psicólogo/a te ayudará a entender qué puede cambiar y qué se mantiene más estable.

¿Por qué algunos resultados son mejores que otros?

Es completamente normal. Todas las personas tienen áreas donde son más fuertes y áreas donde pueden mejorar. Esto NO significa que haya algo mal: el cerebro humano es diverso y cada uno tiene su propio perfil.

¿Qué es el 'cociente intelectual' (CI)?

El CI es un número que resume el rendimiento global en diversas pruebas. NO define tu inteligencia total ni tu valor como persona: es solo una medida parcial de ciertas habilidades de razonamiento, memoria y atención. Varía según el contexto, la fatiga, el ánimo del día y muchos otros factores.

¿Qué hago con las áreas donde me fue muy bien?

¡Celebra y potencia esas fortalezas! Pueden ser tu ancla para compensar las áreas que requieren más esfuerzo. Compartir esto con tu familia, colegio o terapeuta les permite diseñar estrategias que aprovechen lo que mejor te sale.

IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA

DSM-5 / CIE-10

Diagnóstico codificado

Código CIE-10: F07

Impresión diagnóstica: F07.2 - Síndrome post-concusional + demanda laboral activa

RECOMENDACIONES

Plan de manejo agrupado por área y prioridad

Familiar

- Psicoeducación a esposa e hijos sobre el perfil de secuela, manejo conductual en casa, expectativas realistas de recuperación.

General

- [LABORAL] Paciente presenta SECUELAS COGNITIVAS SIGNIFICATIVAS compatibles con síndrome post-concusional crónico. Capacidad laboral residual estimada: 40-50% de su nivel pre-lesional.
- [LABORAL] Implicaciones para la demanda: Las alteraciones en funciones ejecutivas y memoria documentadas SON CONSISTENTES con el TEC moderado del 2025-08-15 (mecanismo plausible, temporalidad coherente, perfil neuropsicológico típico).
- [LEGAL] Documentación completa disponible para el juzgado. Se anexa: batería administrada, resultados normativos, análisis de validez, correlación anátomo-clínica, y respuesta a cada pregunta del auto interlocutorio.
- [LABORAL] Limitaciones específicas: no apto para trabajo en alturas, no apto para tareas que requieran alta velocidad de procesamiento o toma rápida de decisiones en condiciones de riesgo. Requiere supervisión y pausas estructuradas.

Terapéutica

- Indispensable: programa de rehabilitación neuropsicológica de 6 meses (mínimo 24 sesiones) con foco en funciones ejecutivas y estrategias compensatorias de memoria.
- Tratamiento farmacológico de la sintomatología depresiva-ansiosa por psiquiatría (ISRS). Psicoterapia breve de apoyo.

Recomendaciones del cuadro clínico

Banco de recomendaciones clínicas sugeridas para el cuadro identificado. El clínico debe seleccionar las aplicables antes de emitir el informe definitivo.

Discapacidad intelectual adulto (F70–F79) · Adulto (18–49 años)

- Valoración para proceso de interdicción / apoyos legales según Ley 1996 de 2019.
- Programa de inclusión laboral / ocupacional adaptado a su nivel.
- Entrenamiento en AVD y autonomía: transporte, manejo de dinero, autocuidado.
- Acompañamiento psicosocial para red de apoyo familiar.
- Manejo de comorbilidades psiquiátricas (ansiedad, depresión) — frecuentes.
- Control médico integral — mayor riesgo de enfermedades no detectadas por dificultad para comunicar síntomas.
- Actividades de estimulación cognitiva adaptadas al nivel funcional.
- Psicoeducación sexual y prevención de abuso.